

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA (ACE-Q)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Trauma Acumulado, Estrés Tóxico y Resiliencia Biográfica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia (ACE-Q / ACE Screener).
Nombre Original (Inglés)	<i>Adverse Childhood Experiences Questionnaire (ACE-Q) — Adult Version</i>
Autores del Estudio Seminal	Dr. Vincent J. Felitti (Kaiser Permanente) y Dr. Robert F. Anda (CDC, EE. UU.), 1998.
Estandarización y Algoritmo	Comité Consultivo Clínico de <i>ACEs Aware</i> / Oficina del Cirujano General de California (Dr. Nadine Burke Harris et al., 2020, 2023).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Instrumento de cribado biomédico y psicosocial de adversidad temprana acumulada.
Modalidad de Aplicación	Autoinforme individual estructurado o heteroaplicado en entrevista clínica trauma-informada.
Población Objetivo	Adultos (≥ 18 años), con evaluación retrospectiva de sucesos acontecidos antes de cumplir los 18 años.
Tiempo de Aplicación	Aproximadamente 3 a 5 minutos (prueba de cribado ultrarrápida y no invasiva).
Estructura y Formato	10 categorías de adversidad dicotómicas (SÍ / NO) organizadas en 3 dominios clínicos + 1 ítem de percepción de impacto en la salud.
Estatuto de Licencia / Acceso	Dominio público científico. Documento oficial de libre reproducción y uso clínico sin fines comerciales (material gubernamental CDC / Estado de California). No requiere pago de cánones editoriales.

2. FUNDAMENTACIÓN NEUROBIOLÓGICA Y FISIOPATOLOGÍA DEL ESTRÉS TÓXICO

El constructo de **Estrés Tóxico** (Shonkoff et al., 2012; Burke Harris, 2018) describe la activación intensa, repetida y prolongada de los sistemas neuroendocrinos y de respuesta al estrés en ausencia de relaciones protectoras que actúen como amortiguadores (*buffering relationships*).

Disregulación Neuroendocrina y Cerebral:

- **Hiperreactividad Amigdalina:** Sensibilización de las redes del miedo y vigilancia constante de amenaza, inhibiendo el aprendizaje asociativo óptimo.
- **Atrofia Hipocampal:** La hipersecreción sostenida de glucocorticoides (cortisol) daña receptores hipocampales, alterando la memoria declarativa y el frenado por *feedback* negativo del eje HPA.
- **Fallas Prefrontales (DLPFC/vmPFC):** Hipofunción ejecutiva, dificultades de regulación afectiva, impulsividad y menor control atencional.

Impacto Inmunológico, Epigenético y Somático:

- **Inflamación Sistémica Crónica:** Elevación sostenida de marcadores inflamatorios (Proteína C Reactiva, interleucina IL-6, TNF- α), desencadenando disfunción endotelial.
- **Modificación Epigenética:** Alteraciones en la metilación del promotor del gen del receptor de glucocorticoides (*NR3C1*).
- **Envejecimiento Celular Prematuro:** Acortamiento acelerado de los telómeros celulares, incrementando la vulnerabilidad a neoplasias y patologías crónicas.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL Y DOMINIOS CLÍNICOS (10 CATEGORÍAS ACES)

Dominio Clínico	Categoría ACE	Definición Operacional y Criterio de Presencia
I. ABUSO (Personal / Dirigido)	1. Abuso Emocional 2. Abuso Físico 3. Abuso Sexual	Insultos, amenazas, humillaciones o menosprecios habituales por cuidadores. Golpes, bofetadas, palizas o agresiones físicas con daño corporal. Tocamientos no deseados, manoseos, actos sexuales forzados o intento de violación.
II. NEGLIGENCIA (Omisión de Cuidados)	4. Negligencia Física 5. Negligencia Emocional	Carencia crónica de alimentos suficientes, ropa limpia, cobijo seguro o atención médica. Percepción de falta total de cariño, apoyo, cercanía familiar o importancia biográfica.
III. DISFUNCIÓN FAMILIAR (Contexto del Hogar)	6. Ruptura Parental 7. Violencia Doméstica 8. Consumo de Sustancias 9. Enfermedad Mental 10. Encarcelamiento	Separación, divorcio, abandono o muerte temprana de los progenitores. Presenciar violencia física o agresiones directas hacia la madre/cuidador. Convivencia con adultos adictos al alcohol, drogas o psicofármacos en el hogar. Convivencia con un familiar deprimido grave, psicótico o con intento de suicidio. Algún miembro del núcleo de convivencia condenado o recluso en prisión.

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA (PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS)

El ACE-Q cuenta con sólida evidencia de validez de constructo y predictiva demostrada en el estudio clásico CDC-Kaiser (Felitti et al., 1998; N > 17.000) y replicaciones transculturales: correlaciona linealmente con biomarcadores inflamatorios crónicos (PCR, IL-6) y respuesta fisiológica de estrés tóxico.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN, BAREMOS Y MATRIZ DE RIESGO CLÍNICO (AAHC)

Nivel de Riesgo	Puntuación ACE	Criterio Clínico y Condiciones Asociadas (AAHC)	Conducta Clínica Recomendada
RIESGO BAJO	0 ACEs	Sin adversidad infantil acumulada documentada. Fisiología de estrés conservada.	Educación en factores protectores, hábitos de bienestar y promoción de resiliencia.
RIESGO INTERMEDIO	1 a 3 ACEs (Sin AAHC)	Presencia de adversidad pero sin afecciones físicas o psiquiátricas asociadas documentadas.	Psicoeducación en respuesta al estrés, regulación emocional y monitoreo en revisiones anuales.
RIESGO ALTO	1 a 3 ACEs (Con AAHC) o bien ≥ 4 ACEs (Con/sin AAHC)	Evidencia clínica de Respuesta Fisiológica de Estrés Tóxico (TSR) activa. Alta susceptibilidad o presencia de múltiples patologías inflamatorias y afectivas crónicas.	Plan de intervención multidisciplinar intensivo, psicoterapia focalizada en trauma y abordaje médico integrado.

5. CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS A ACES (AAHC) Y EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA

Patología Médica / Somática (AAHC)	Odds Ratio (≥ 4 vs 0)	Trastorno Psiquiátrico / Conductual	Odds Ratio (≥ 4 vs 0)
Enfermedad Pulmonar Obstructiva (EPOC)	OR = 3.1	Trastorno Depresivo Mayor	OR = 3.9 – 4.5
Accidente Cerebrovascular (Ictus / ACV)	OR = 2.0	Intentos de Suicidio (en la vida)	OR = 12.2
Cardiopatía Isquémica / Infarto (IAM)	OR = 2.1	TDAH en la adultez	OR = 5.0
Asma Crónica del Adulto	OR = 2.2	Trastorno por Abuso de Alcohol	OR = 7.4
Cáncer (cualquier localización)	OR = 2.3	Consumo de Drogas Intravenosas	OR = 10.3
Diabetes Mellitus Tipo 2 y Obesidad	OR = 1.4 – 2.1	Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)	OR = 4.0 – 5.2
Fibromialgia, Cefaleas y Dolor Crónico	OR = 1.8 – 2.1	Conductas de Automutilación / Autolesión	OR = 1.8 por ACE

6. ATENCIÓN INFORMADA EN TRAUMA (TIC) Y LAS 6 ESTRATEGIAS REGULADORAS

El enfoque clínico *Trauma-Informed Care (TIC)* transforma el paradigma terapéutico: en lugar de preguntar «¿Qué le pasa / qué tiene de malo?», indaga «¿Qué le ha sucedido y cómo su organismo se adaptó para sobrevivir?». El Cirujano General de California protocoliza **6 estrategias reguladoras neurovegetativas** con respaldo empírico:

- 1. Relaciones Interpersonales Amortiguadoras:** Conexiones afectivas seguras que estimulan oxitocina y calman la amígdala.
- 2. Higiene y Restauración del Sueño:** 7–9 h de descanso regular para favorecer el drenaje linfático y regular el eje HPA.
- 3. Nutrición Antiinflamatoria:** Dieta rica en antioxidantes, fibra y omega-3; modula el eje microbiota-intestino-cerebro.
- 4. Ejercicio Aeróbico Regular:** Incrementa el BDNF, reduce citoquinas proinflamatorias y descarga tensión simpática.
- 5. Regulación Autonómica y Mindfulness:** Respiración diafragmática (tono vagal), coherencia cardíaca y meditación.
- 6. Psicoterapia Focalizada en Trauma:** Abordajes de reprocesamiento neuroemocional basados en evidencia (EMDR, TF-CBT).

7. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO CON RESOLUCIÓN PASO A PASO

Motivo de Consulta: Paciente femenina de 38 años, abogada corporativa, derivada a interconsulta por presentar crisis de angustia recurrentes, insomnio grave resistente a hipnóticos y dolor musculoesquelético generalizado (recientemente diagnosticada de fibromialgia refractaria).

Registro Dicotómico en el Protocolo ACE-Q (Vivencias antes de los 18 años):

• **Ítems Afirmativos (SÍ):**

- Ítem 2: Ruptura familiar traumática (divorcio conflictivo con desamparo a los 8 años). **+1**
- Ítem 3: Convivencia con madre con depresión mayor recurrente e intentos de autolisis. **+1**
- Ítem 5: Violencia intrafamiliar física presenciada de forma habitual entre progenitores. **+1**
- Ítem 7: Abuso emocional directo (humillaciones y descalificaciones sistemáticas). **+1**
- Ítem 9: Negligencia emocional crónica (sensación vivencial de «no ser querida ni importante»). **+1**

• **Ítems Negativos (NO):** Ítem 1 (Negligencia física), Ítem 4 (Sustancias), Ítem 6 (Cárcel), Ítem 8 (Abuso físico), Ítem 10 (Abuso sexual).

• **Pregunta de Impacto Percibido:** Responde «Mucho».

Cálculos y Dictamen Clínico-Psicométrico:

1. **Puntuación Total ACE:** $1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$ / 10 ACEs acumuladas.
2. **Estratificación según Algoritmo ACEs Aware:** Puntuación ≥ 4 + presencia de Condiciones Asociadas a ACEs (Fibromialgia + Crisis de Pánico + Insomnio) = **RIESGO ALTO DE RESPUESTA DE ESTRÉS TÓXICO (TSR)**.
3. **Formulación del Caso e Intervención:**
 - **Psicoeducación Desculpabilizadora:** Se explica a la paciente cómo la sobreactivación sostenida del eje HPA en su infancia configuró un estado biológico proinflamatorio crónico que fundamenta fisiológicamente su dolor musculoesquelético y sus crisis de pánico.
 - **Plan de Regulación Multidisciplinar:** Prescripción de las 6 estrategias reguladoras (higiene circadiana, entrenamiento en coherencia cardíaca vagal y nutrición antiinflamatoria).
 - **Derivación Terapéutica:** Derivación a psicoterapia especializada de reprocesamiento del trauma (EMDR) y coordinación con el servicio de medicina interna/reumatología.

8. PAUTAS ÉTICAS Y PRINCIPIO DE RESILIENCIA EN EVALUACIÓN DE TRAUMA

Salvaguardas Éticas y No Re-traumatización:

Cribado no estigmatizante; el paciente tiene derecho de omisión. No indagar en detalles gráficos de vivencias traumáticas en cribado inicial.

Principio de Resiliencia y Neuroplasticidad:

El cerebro conserva plasticidad; vínculos seguros y terapia informada en trauma (TIC/EMDR) neutralizan la carga alostática acumulada.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA, RIESGO SUICIDA Y PROTECCIÓN LEGAL

NOTIFICACIÓN DE MALTRATO ACTIVO:

Si la evaluación se realiza en un menor o persona vulnerable y se constata abuso sexual, físico o desamparo en curso, rige la obligación legal de notificación inmediata a fiscalía o servicios de protección de menores.

RIESGO AUTOLÍTICO EN POLIVICTIMIZACIÓN:

Puntuaciones ACEs ≥ 4 multiplican exponencialmente el riesgo de intentos de suicidio y autolesiones. Es mandatorio cribar ideación autolítica activa (C-SSRS) y activar plan de seguridad clínico ambulatorio.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Felitti, V. J., Anda, R. F. et al. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death: The ACE Study. *Am J Prev Med*, 14(4), 245–258.
- Anda, R. F., Felitti, V. J. et al. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*, 256(3), 174–186.
- Burke Harris, N. (2018). *The Deepest Well: Healing the Long-Term Effects of Childhood Adversity*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Hughes, K., Bellis, M. A. et al. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: systematic review. *Lancet Public Health*, 2(8), e356–e366.
- Bucci, M., Marques, S. S. et al. (2020). Toxic stress in children and adolescents: Clinical implications and screening for ACEs. *Pediatr Ann*, 49(11), e472–e478.
- Office of the California Surgeon General. (2023). *ACEs Aware Clinical Assessment and Treatment Algorithm*. State of California.